TEMA 27 · Cuidados de la mujer en el climaterio. Fomento de hábitos saludables. Educación para la salud individual y grupal

Resumen OPE Enfermería SMS · Conceptos y STRAW+10, fisiopatología hormonal, síndrome climatérico, escalas (Cervantes, FRAX, Goldberg), plan de cuidados, hábitos saludables, tratamiento médico, educación para la salud y programa grupal, y cribados en Atención Primaria

1. Conceptos

- **Climaterio**: etapa **fisiológica** de transición (no una enfermedad) desde la vida reproductiva hasta la senectud, por agotamiento folicular y caída de estrógenos y progesterona.
- **Menopausia**: **fecha** de la última regla; diagnóstico **retrospectivo** tras **12 meses de amenorrea** sin otra causa. Edad media **≈ 50 años**; **precoz** (insuficiencia ovárica primaria) **< 40 años**; tardía **> 55 años**.
- **Premenopausia** (años previos, ciclos regulares con cambios sutiles), **perimenopausia** (declive más acusado hasta 1 año después de la última regla: irregularidad y **sofocos**; **la fase con más síntomas**) y **posmenopausia** (desde 1 año después hasta el final de la vida: ≈ **un tercio de la vida**; prioridad preventiva cardiovascular y ósea).
- **STRAW+10**: estadios −5 a +2 con la última regla como 0. Transición temprana (−2): variación del ciclo **≥ 7 días**; tardía (−1): amenorreas **≥ 60 días** y FSH > 25 UI/l. Posmenopausia temprana (+1, unos 6 años): **máxima pérdida ósea**; tardía (+2): síndrome genitourinario.

2. Fisiopatología

- Orden de los cambios: **primero baja la hormona antimülleriana (AMH)** → baja la **inhibina B** → **sube la FSH** (ciclos más cortos: **polimenorrea**, primer signo) → **cae el estradiol**. La menopausia es un estado **hipergonadotrópico** (FSH y LH altas) e **hipoestrogénico**.
- **AMH**: el marcador **más precoz y fiable** de reserva ovárica; **no varía con el ciclo** (puede extraerse cualquier día).
- En la posmenopausia predomina la **estrona** (menos potente), formada por **aromatización** de la androstendiona en el **tejido adiposo**: en la **obesidad**, el estímulo estrogénico sin progesterona aumenta el riesgo de **hiperplasia y cáncer de endometrio**.

3. Clínica

- **Sofocos y sudoración nocturna**: la queja principal; alteración del centro termorregulador; insomnio y fatiga. Son **transitorios**. Descartar **disfunción tiroidea (TSH)**.
- **Síndrome genitourinario de la menopausia**: **crónico y progresivo**: mucosa fina, menos glucógeno, desaparecen los **lactobacilos de Döderlein** y el **pH sube (> 5)**; sequedad, prurito, **dispareunia**, disuria, urgencia e infecciones. Infradiagnosticado: **preguntar activamente**.
- **Osteoporosis** (pérdida máxima en los **primeros 5 años**): **DXA, T-score**: **≥ −1 normal**; **−1 a −2,5 osteopenia**; **≤ −2,5 osteoporosis** (grave si además hay fractura por fragilidad).
- **Cardiovascular**: **baja el HDL**, suben LDL y triglicéridos; grasa **androide** (abdominal) y resistencia a la insulina: el riesgo se iguala al del varón.
- **Psicosocial**: **nido vacío** y **generación sándwich** (cuida a hijos y padres): estrés, ansiedad, depresión, riesgo de claudicación.

4. Valoración

- Entrevista: factores de riesgo cardiovascular, **tabaco** (adelanta la menopausia y acelera la pérdida ósea), antecedentes oncológicos y de fracturas.

Escala	Mide	Claves
Cervantes (versión corta de 16 ítems)	**Calidad de vida** en la menopausia (validada en España)	**A mayor puntuación, peor calidad de vida**
FRAX (OMS)	**Riesgo de fractura a 10 años** (mayor y de cadera)	Pronóstico, **no diagnóstico**; puede calcularse **sin densitometría** (edad, IMC, tabaco, alcohol, corticoides, artritis reumatoide, fractura de cadera en los padres)
Goldberg	Ansiedad y depresión	Probable **ansiedad ≥ 4**; **depresión ≥ 2** respuestas afirmativas

5. Plan de cuidados (patrones de Gordon)

Patrón	NANDA	NIC y actividades
Nutricional	**Riesgo de sobrepeso**	Asesoramiento nutricional; recordatorio de 24 h; evitar **picantes, cafeína, alcohol y cenas copiosas** (desencadenan sofocos)
Eliminación	**Incontinencia urinaria de urgencia** (atrofia del urotelio)	**Entrenamiento vesical** (alargar intervalos) y **ejercicios del suelo pélvico**
Sueño	**Insomnio** (sofocos)	Mejorar el sueño: habitación fresca y oscura, ropa por capas, respiración diafragmática
Sexualidad	**Disfunción sexual** (dispareunia)	Asesoramiento sexual: hidratantes y lubricantes, sexualidad no centrada en el coito
Autopercepción	**Trastorno de la imagen corporal**	Apoyo emocional, potenciación de la autoestima

6. Hábitos saludables

- **Dieta mediterránea** rica en fibra y de bajo índice glucémico. **Calcio: 1.000 mg/día hasta los 50 años y 1.200 mg/día desde los 51**, con vitamina D (lácteos, sardinas con espinas, crucíferas, bebidas enriquecidas). **Exceso de sal y cafeína aumenta la pérdida urinaria de calcio**.
- **Isoflavonas de soja** (genisteína, daidzeína): actúan sobre el **receptor estrogénico beta** (agonistas débiles; neutras en mama y endometrio) y reducen los sofocos; solo el **30-50%** de las mujeres tiene la flora que produce **equol** (por eso a veces no funcionan).
- **Ejercicio**: aeróbico y **de fuerza** (el factor aislado más importante para **prevenir caídas y fracturas**). **Kegel**: contraer **10 s** y relajar **10 s**, 10-15 repeticiones, 3-5 veces al día, sin glúteos ni abdominales. **Hipopresivos**: presión **negativa** que eleva las vísceras (prolapsos).
- **Tabaco**: el factor modificable que **adelanta** la menopausia (apoptosis folicular). **Alcohol**: empeora los sofocos.

7. Tratamiento médico

- **Síndrome genitourinario**: primero **hidratantes vaginales** (ácido hialurónico; **uso continuo**, 2-3 veces por semana) y **lubricantes** acuosos (**a demanda**, en el coito). Después **estrógenos vaginales a dosis bajas** (estriol, estradiol, promestrieno): absorción mínima, **no requieren progestágeno**. **Ospemifeno** oral si no pueden usarse.
- **Terapia hormonal sistémica**: de elección en los **sofocos moderados-graves**, solo en **< 60 años o < 10 años** desde la menopausia. **Contraindicaciones absolutas**: **cáncer de mama**, tumores estrógeno-dependientes (endometrio), **sangrado genital no filiado**, **tromboembolismo venoso**, enfermedad arterial activa (IAM, ictus), hepatopatía aguda grave y porfiria.
- **No hormonales**: **fezolinetant** (antagonista del receptor **NK3** hipotalámico), **paroxetina 7,5 mg** (**contraindicada con tamoxifeno**: inhibe el CYP2D6), **venlafaxina** (de elección **si toma tamoxifeno**) y **gabapentina** (sofocos nocturnos con insomnio).

8. Educación para la salud

- Basada en el **aprendizaje significativo** (partir de lo que la mujer sabe y vive). Áreas: **cognitiva** (saber), **emocional** (sentir) y **de habilidades** (saber hacer: aplicar óvulos, leer etiquetas).
- **Individual**: relación horizontal; secuencia **expresión (preguntas abiertas) → análisis (resumen, confrontación suave) → información** dosificada; el **silencio** es una técnica activa.
- **Grupal**: talleres de **8-15 personas**; la enfermera modera. Técnicas: **investigación en el aula** (tormenta de ideas, **foto-palabra**: sacar ideas previas), **exposición participada**, **análisis** (prensa, publicidad: estereotipos) y **desarrollo de habilidades** (**role-playing**, talleres).
- **Programa de climaterio** (captación **oportunista** en AP por síntomas diana: cansancio, dispareunia, cambios del ciclo o del ánimo):

Sesión	Contenido
I	Presentación cruzada por parejas, **grupo nominal** (expectativas) y fisiología básica para despatologizar
II	Calcio y **lectura de etiquetas**, sol (vitamina D), fuerza con bandas, **Kegel**
III	Salud genitourinaria, **productos vaginales**, sexualidad no coitocéntrica
IV	Emociones (nido vacío, cuidados), **relajación de Jacobson**, recursos comunitarios y **evaluación con los cuestionarios (post-test)**

9. Cribados en Atención Primaria

Cribado	Población	Prueba
Mama	50-69 años	Mamografía **cada 2 años**
Cérvix	**35-65 años**	**Test de VPH cada 5 años** (no citología cada 3 años a esta edad); alta a los 65 si los previos fueron negativos
Colorrectal	50-69 años	**Sangre oculta en heces cada 2 años**
Riesgo cardiovascular	—	HTA, diabetes, lípidos; tabla **SCORE2** (países de bajo riesgo)
Violencia de género	Todas	Cribado **oportunista**: hiperfrecuentación, pareja que controla, sexo bajo coacción

TRAMPAS DE EXAMEN

! **Menopausia = 12 meses de amenorrea; precoz < 40 años.**

! Primer marcador del declive ovárico: **AMH**; el estado menopáusico es **FSH alta y estradiol bajo**.

! Cervantes: **más puntos = peor** calidad de vida.

! Tamoxifeno + sofocos: **venlafaxina**, nunca paroxetina.